COMITÉ DE BIOÉTICA EN INVESTIGACIÓN · CLÍNICA GENERAL DEL NORTE

Respuesta a las observaciones bioéticas del protocolo

«Complicaciones mayores y mortalidad intrahospitalaria según el tipo de cirugía cardiaca en pacientes Testigos de Jehová: cohorte retrospectiva en Barranquilla, 2020–2025»

Daily Daniela Torres Villazon · Nestor Fabian Sanabria Duarte
Especialización en Medicina Interna – Universidad Libre, Seccional Barranquilla
Sesión del Comité · 28 de octubre de 2026

zentria

Siete observaciones, analizadas una por una

Mensaje central

La mayoría de las observaciones dieron lugar a modificaciones directas del protocolo.

Frente a redefinir la población solo por rechazo transfusional, se mantuvo la delimitación original y se amplió su fundamentación científica, metodológica, ética y normativa.

Todos los ajustes están resaltados en amarillo en la versión 2.0.

1	Justificación de la población	Se fundamenta
2	Coherencia del protocolo	Se acoge en parte
3	Contexto religioso y temporal	Se acoge
4	Riesgo y consentimiento	Se acoge
5	Protección de datos sensibles	Se acoge
6	Interpretación y publicación	Se acoge
7	Documentación transfusional	Se acoge

Justificación de la población

Observación del Comité *«Fundamentar la selección exclusiva de personas Testigos de Jehová y valorar si la pregunta puede responderse mediante una cohorte definida por rechazo transfusional documentado, independientemente de la afiliación religiosa».*

Se fundamenta

Se mantiene la delimitación: una cohorte definida solo por rechazo respondería otra pregunta y reduciría la comparabilidad.

1 Comparabilidad

Metaanálisis, cohortes emparejadas y series definen su población como Testigos de Jehová; es descriptor DeCS y MeSH.

2 Homogeneidad clínica

En 2020–2025 la negativa era anticipada, estable y documentada; fuera de este grupo es infrecuente, parcial o circunstancial.

3 Precedente metodológico

Pattakos et al. (Cleveland Clinic) estudiaron el rechazo de transfusión en 322 Testigos de Jehová como «experimento natural».

4 Justicia y valor social

La Corte Constitucional ordenó un reemplazo valvular aórtico sin transfusión (T-476 de 2016): la prestación es exigible.

Dónde está en el protocolo v2.0: numeral 1.2, pp. 11–12 · numeral 2.3, pp. 24–25 · numeral 3.2.2, p. 28

Precedentes aprobados por comités de ética

11

estudios con la misma definición poblacional y diseño retrospectivo sobre historias clínicas

Publicados en revistas que exigen declarar la aprobación ética (ICMJE)

Nakano et al., 2026 · InCor, Brasil

Revascularización coronaria; 26 TJ y 78 controles. Comité de ética n.° 7.441.177: dispensa del consentimiento por datos anonimizados, sin contacto con pacientes.

Hartrumpf et al., 2023 · Alemania

TJ consecutivos en cirugía cardiaca mayor, 2003–2022. Comité de ética n.° E-01-20230411: consentimiento escrito no requerido por anonimización completa.

Estudio	País / centro	Población
Pattakos 2012	EE. UU. · Cleveland Clinic	322 TJ, 1983–2011
Langstraat 2023	Países Bajos · Amphia (Breda)	329 procedimientos, 2001–2022
Helwani 2023	EE. UU. · Washington University	48 TJ en cirugía cardiaca
Valle 2017	Brasil · Porto Alegre	16 TJ y 48 controles
Tanaka 2015 · Marinakis 2016	EE. UU. · Bélgica	144 TJ · 31 TJ
Vaislic 2012 · Yamabe 2025	Francia · Japón	500 TJ · 42 TJ
Montes Villalobos (SCC)	Colombia · FCV	30 TJ, 2012–2021

Coherencia del protocolo

Observación del Comité *«Ajustar, si corresponde, título, objetivos, población, criterios de inclusión e identificación de casos. Diferenciar expresamente la identidad religiosa de las decisiones clínicas individuales sobre componentes sanguíneos».*

Se acoge en parte Se incorpora la diferenciación explícita; título, pregunta y objetivos no requieren cambio porque ya eran coherentes.

Afiliación religiosa

Condición de Testigo de Jehová, declarada y registrada. Delimita la población y permite comparar con la literatura.

+

Decisión clínica individual

Aceptación o rechazo de cada componente, fracción o técnica, documentado antes de la cirugía.

=

Elegible
solo con ambas condiciones documentadas

Título y objetivos

Se mantienen: ya exigían el «rechazo transfusional documentado».

Criterio de inclusión 2

Debe constar expresamente la condición de Testigo de Jehová (p. 29).

Criterio de inclusión 4

La religión no se acepta como prueba de la negativa (p. 30).

Base analítica

Sin variable de afiliación religiosa (p. 42); no TJ con rechazo: solo en el flujo (p. 28).

Dónde está en el protocolo v2.0: numeral 3.2.2, p. 28 · numeral 3.3.1, pp. 29–30 · numeral 3.9.1, p. 42

Contexto religioso y temporal

Observación del Comité *«Actualizar el marco teórico con la comunicación del 18 de septiembre de 2026 sobre decisiones individuales respecto de componentes sanguíneos, aclarando que es posterior al período estudiado (2020–2025)».*

Se acoge Se actualizó el contexto en el marco teórico y se delimitó frente al periodo de estudio.



Se rechazaban la sangre completa y sus cuatro componentes principales; fracciones y técnicas autólogas en circuito continuo eran decisión individual.

Sangre propia almacenada: decisión individual

Componentes principales: decisión de conciencia; se mantiene el rechazo de sangre completa

No cambia la elegibilidad

Depende de la negativa individual registrada antes de la cirugía índice, no de la doctrina vigente.

Delimita la validez temporal

Los resultados no se extrapolarán a pacientes atendidos después de septiembre de 2026.

Cohorte histórica

Documenta un periodo cerrado y refuerza la distinción entre afiliación y decisión clínica.

Dónde está en el protocolo v2.0: p. 6 · numeral 2.1.5, p. 18 · numeral 3.7.1, p. 35 · numeral 3.9.2, p. 43 · referencias 51–53

Clasificación del riesgo

Observación del Comité *«Sustentar la clasificación del riesgo y la eventual dispensa del consentimiento informado conforme a la Resolución 8430 de 1993, sin asumir que la naturaleza retrospectiva concede una dispensa automática».*

Se acoge

El carácter retrospectivo no se presume suficiente: riesgo y dispensa se sustentan por separado, sujetos a la valoración del Comité.

Supuesto del art. 11, literal a)	Cómo lo cumple el estudio
Investigación documental retrospectiva	Solo revisión de historias y registros, sin intervención ni modificación intencionada de variables.
No se identifica al participante	Seudonimización desde la extracción, claves separadas y resultados agregados.
No se tratan aspectos sensitivos de la conducta	No se indagan ni valoran prácticas, creencias o conductas; la condición religiosa solo delimita la población.

Sin riesgo

Resolución 8430 de 1993, art. 11 a)

El riesgo previsible es informacional. Como la condición religiosa es un dato sensible (Ley 1581 de 2012), su tratamiento tiene las salvaguardas reforzadas del numeral 3.9.1.

Dónde está en el protocolo v2.0: numeral 3.9, p. 40 · numeral 2.3.2, p. 25

Dispensa del consentimiento informado

La dispensa no se fundamenta en el carácter retrospectivo, sino en cinco condiciones concurrentes (Res. 8430, art. 16 par. 1; Ley 1581 de 2012; pauta 10 de CIOMS-OMS).

1

Sin riesgo

Requisito del parágrafo primero del artículo 16.

2

Impracticable

Pacientes de 2020–2025, una parte fallecidos; exigirlo excluiría a los de peor desenlace y sesgaría la estimación.

3

El contacto aumenta el riesgo

Obligaría a manipular identificadores y revelaría datos religiosos y transfusionales a terceros.

4

Valor social

Seguridad perioperatoria de un grupo cuyo derecho a la cirugía sin transfusión reconoce la Corte.

5

Garantías legales

Finalidad científica y supresión de identidad (Ley 1581, art. 6 e y art. 10 d).

Dónde está en el protocolo v2.0: numeral 3.9, p. 41 · numeral 2.3.1, p. 24 · numeral 2.3.2, p. 25

Protección de datos sensibles

Observación del Comité *«Describir responsables y controles de acceso, codificación, almacenamiento, custodia de claves y manejo de incidentes. Prevenir la identificación indirecta y la divulgación no autorizada de datos clínicos o religiosos (Ley 1581 de 2012)».*

Se acoge Se incorporó el numeral 3.9.1, «Plan de protección de datos personales y sensibles».

1 Responsables

Clínica: responsable del tratamiento. Investigadores: encargados (art. 18).

2 Accesos

Credenciales individuales, solo consulta, en la red de la Clínica; sin copias ni dispositivos externos.

3 Codificación

Código aleatorio sin alusión religiosa; fechas relativas; sin variable de religión.

4 Almacenamiento

REDCap institucional o archivo cifrado; respaldos cifrados; conservación por cinco años.

5 Custodia de claves

Archivo cifrado aparte, accesible solo a los investigadores; nunca se transmite con la base.

6 Incidentes

Contención el mismo día; aviso en 24 h a la Clínica y al Comité; reporte a la SIC (art. 17 n).

7 Identificación indirecta

Celdas menores de 5 suprimidas, edad por grupos, sin casos individuales ni fechas.

8 Minimización

Solo los pacientes del listado de elegibilidad y las variables del diccionario.

Dónde está en el protocolo v2.0: numeral 3.9.1, pp. 42–43 · numeral 3.4, p. 31

Interpretación y publicación

Observación del Comité *«Definir medidas para evitar inferencias causales indebidas, atribuciones de complicaciones a la religión y tablas o descripciones que puedan identificar o estigmatizar a los pacientes».*

Se acoge Se agregó el numeral 3.9.2, «Interpretación y publicación de los resultados».

No haremos

- Afirmar causalidad, seguridad o equivalencia.
- Atribuir desenlaces a la religión o a la decisión del paciente.
- Publicar casos individuales, fechas o cruces identificables.
- Emitir comunicados o publicar en redes sin autorización institucional.

Haremos

- Expresar resultados como frecuencia y asociación.
- Relacionar complicaciones con factores clínicos y con el manejo de la sangre.
- Usar lenguaje respetuoso: «pacientes con rechazo transfusional documentado».
- Revisar antes de difundir y remitir el informe final al Comité.

Dónde está en el protocolo v2.0: numeral 3.9.2, p. 43 · numeral 3.9.1, p. 43 · numeral 3.10, p. 44

Documentación transfusional

Observación del Comité *«Precisar cómo se verificarán la negativa documentada, el producto sanguíneo involucrado, los cambios de voluntad y las circunstancias de cualquier transfusión registrada».*

Se acoge Se agregó el procedimiento «Verificación de la documentación transfusional» y tres variables en la Tabla 3.

1 Negativa
Tipo de documento, fecha, firma y profesional; válida solo si es escrita y previa a la cirugía.

2 Producto
Aceptación, rechazo o ausencia de registro de cada componente, fracción y técnica autóloga.

3 Cambio de voluntad
Fecha, fase, quién lo expresa (paciente o representante) y soporte.

4 Transfusión
Triangulación: servicio transfusional, anestesia o enfermería y notas médicas.

Clasificación de la circunstancia de cada transfusión

- Con consentimiento o cambio de voluntad
- Emergencia sin capacidad
- Orden judicial o administrativa
- Sin circunstancia documentada
- No concluyente

100 % de los pacientes con doble revisión independiente
Sin juicio de legalidad ni de responsabilidad; datos solo agregados.

Dónde está en el protocolo v2.0: numeral 3.5, pp. 32–33 · Tabla 3, p. 38 · numeral 3.9, p. 41

Respuesta a las siete observaciones

N.º	Observación	Respuesta	Ajuste principal	Páginas
1	Población	**Se fundamenta**	Se mantiene la delimitación; fundamentación y precedentes	11–12, 24–25
2	Coherencia	**Se acoge en parte**	Identidad religiosa ≠ decisión clínica; criterios 2 y 4	28–30
3	Contexto 2026	**Se acoge**	Cambios de marzo y septiembre; validez temporal	6, 18, 35
4	Riesgo y consentimiento	**Se acoge**	Supuestos del art. 11; cinco condiciones de dispensa	40–41
5	Datos sensibles	**Se acoge**	Plan de protección de datos (numeral 3.9.1)	42–43
6	Interpretación y publicación	**Se acoge**	Reglas de interpretación y difusión (numeral 3.9.2)	43–44
7	Documentación transfusional	**Se acoge**	Doble verificación, triangulación y 3 variables nuevas	32–33, 38

Compromisos del equipo investigador

1. No revisar historias clínicas antes del aval del Comité y de la autorización institucional.
2. Someter al Comité cualquier enmienda del protocolo antes de aplicarla.
3. Notificar al Comité cualquier incidente de seguridad de la información en las 24 horas siguientes.
4. Atender cualquier aclaración adicional y sustentar el protocolo cuando el Comité lo requiera.

Solicitud

Respetuosamente solicitamos al Comité considerar la emisión del aval ético para la versión 2.0 del protocolo.

Gracias

Quedamos atentos a las preguntas y observaciones del Comité.

zentria